2.**浸润性突眼/Graves 眼病**/甲状腺相关性眼病/**GO**：眶后组织自身免疫炎症反应

（眶后成纤维细胞表面存在 TSH 受体，淋巴细胞→TSAb 刺激 TSH 受体→透明质酸等黏多糖分泌↑）

①GO 女性多见，但男性临床表现更重　一般:甲状腺疾病女性多见 特殊:周期性瘫痪男性多见

②43%甲亢与 GO 同时发生，44%甲亢先于 GO 发生，5%仅有 GO 而无甲亢症状（甲状腺功能正常型眼病-亚临床甲亢中的一类）

③突眼度更重：突眼度超过参考值≥3mm

④眼部红肿、眼球活动受限、眼内异物感等





⑤**GO 活动期**（1238）

指标	视力下降≥1 行
	突眼度增加≥2mm，眼睑充血、结膜充血，自发性球后疼痛、眼球运动时疼痛　2个“血”2个“痛”
	眼睑肿胀、球结膜肿胀（复视）、泪阜肿胀　球结膜肿胀无需看近物就会有复视　3个“肿”
	任一方向眼球运动减少≥8 度
治疗	可给糖皮质激素（糖皮质激素可致低钾）保钠排水排钾

⑥GO 严重程度（真软突击教室）：

表 7-5-3　GO 严重程度分级标准(美国甲状腺学会)

分级	标准
0	无症状或体征(no physical signs or symptoms)
1	仅有体征,无症状。体征仅有上睑挛缩、凝视,突眼度在 18mm 以内(only signs,no symptoms)
2	软组织受累(soft tissue involvement)
3	眼球突出(proptosis)
4	眼外肌受累(extraocular muscle involvement)
5	角膜受累(corneal involvement)
6	视力丧失(sight loss)

看到黏液性水肿第一反应一定是甲减

（四）少数患者可有胫前黏液性水肿

甲亢黏液性水肿　产生多	**甲减黏液性水肿** 分解少
少数患者	几乎都有
TSAb作用于成纤维细胞表面的TSH受体 **局限**性（胫骨前最多见）	全身性
淋巴细胞→成纤维细胞亢进→透明质酸等黏多糖聚集	透明质酸酶活性下降→透明质酸等黏多糖聚集
水肿程度与自身**免疫**反应程度有关	水肿程度与甲状腺激素水平有关

三、甲亢的检查

1.基础代谢率 BMR↑　甲状腺肿大不能反映甲亢的严重程度

①**BMR=脉率+脉压-111**

②判断甲亢**严重程度：轻度 20-30%、中度 30-60%、重度 60%以上**　236

③甲亢术前准备要求：BMR＜**20%**

2.**TSH↓**　甲亢:T3、T4↑→TSH↓(负反馈)

①**诊断甲亢**的主要指标

②反映甲状腺功能**最敏感**的指标，能用于**筛查**甲亢、诊断**亚临床**甲亢